

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGÍA	
	Historia # 00010	Fecha De Impresión: 04-08-2025 18:51:54

Datos Personales							
Nombre:	GENESIS DANIELA PADILLA DAMIAN	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2017-06-15	Edad	8 Años, 1 Meses, Y 19 Días
Identificación:	TI - 1137878833	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Carolinahurtadodamian@gmail.Com - 1137878833			Dirección:	Carrera 13 Casa #5-20 Barrio Muni , San Diego		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		CAROLINA - Parentesco (madre) - Teléfono (321 6828310)					

Apertura psicología del 2025-08-04 17:51:54: 8 años, 1 meses, y 19 días

DATOS GENERALES
Remisión Particular
Código de consulta 890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA
Motivo de Consulta Refiere la madre "Noto que la niña a nivel social es muy inmadura" "veo que su edad no está acorde a su edad mental" "no logra narrar los hechos de alguna situación" "no construye las frases" "en el colegio antes se quedaba ida y a veces no socializaba" "cuando era niña ella no miraba, se mantenía como ida, se iba de un lado a otro corriendo y camina empinada, no le gustaba mucho el ruido" "le gusta mucho organizar las cosas pequeñas por colores".
Enfermedad Actual Paciente pediátrica cuyos cuidadores refieren signos de inmadurez en el desarrollo social, dificultades en la comprensión y un desfase notable entre la edad cronológica y el desarrollo cognitivo y lingüístico esperado. Se evidencian problemas para estructurar frases y narrar hechos, así como dificultades para seguir instrucciones simples, lo cual limita su desempeño en contextos escolares y sociales. Presenta un retraso en el lenguaje expresivo, con dificultad para articular fonemas específicos como la letra "R". En la infancia mostró escasa respuesta al contacto visual, tendencia a la desconexión del entorno, conductas repetitivas (como correr de un lado a otro o caminar en puntas de pie), hipersensibilidad al ruido y patrones de juego rígidos, organizando objetos pequeños por colores. Estas manifestaciones indican posibles alteraciones en el desarrollo del lenguaje, la comprensión verbal, la interacción social y la flexibilidad cognitiva, por lo que se sugiere una evaluación integral para descartar o confirmar condiciones del neurodesarrollo, como los Trastornos del Espectro Autista u otros trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.

ANTECEDENTES	
Médicos Personales	
Quirúrgico No Refiere	Tóxicos No Refiere
Traumáticos Ninguno	Medicación No Refiere
Paraclínicos Tomografía Simple De Cráneo Bajo Sedacion Con Resultados Normales.	Hospitalizaciones Recién Nacida (Diarrea Durante 8 Días)
Patología No Refiere	

ANTECEDENTES	
Prenatales	
Edad De La Madre En El Embarazo 30 Años	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo Cuarto	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo Si	Estado De La Madre Durante El Embarazo Normal

ANTECEDENTES
Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Cesáreas Anteriores
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer NA
Talla Al Nacer NA	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido Diarrea (hospitalización Durante 8 Días)	Desarrollo Psicomotor NA
--	------------------------------------

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 3M	Rolado 4M
Sedente Solo 6M	Gateo 8M
Bípedo Sin Ayuda 10M	Marcha 14M
Lenguaje Verbal 5 AÑOS	Lenguaje Verbal Fluido 7 AÑOS

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo Padre
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Cáncer Abuela Materna, Hipertensión Y Diabético Abuelo Materno	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa La paciente cursa actualmente segundo grado en la institución educativa Pasitos Feliz, ubicada en el municipio de San Diego. Se reporta un desempeño académico adecuado en general; sin embargo, presenta dificultades en la comprensión lectora cuando los textos son extensos o con estructuras complejas. Históricamente se ha observado que, en el contexto escolar, solía mostrarse ausente o poco participativa, aunque en el presente se evidencia una mayor disposición a integrarse con sus compañeros. A pesar de esta mejoría, aún tiende al aislamiento, situación que podría estar relacionada con sentimientos de rechazo o dificultades en la percepción social.
Historia laboral No aplica
Historia familiar La paciente reside actualmente con su núcleo familiar conformado por el padre, señor Ilber Padilla (42 años), la madre, señora Carolina Damián (38 años), y sus hermanos Daniel Alejandro (22 años), Melani Andrea (15 años) e Ilber Andrés (14 años). Se reporta una convivencia armónica y una relación familiar adecuada, con vínculos estables y funcionales entre los miembros del hogar. No se evidencian, hasta el momento, dinámicas conflictivas significativas dentro del sistema familiar.
Historia social En el contexto social, se observa una evolución positiva en los procesos de interacción, ya que actualmente la paciente logra integrarse con mayor frecuencia a las actividades grupales. Sin embargo, persiste una tendencia al aislamiento en determinadas situaciones, probablemente relacionada con la percepción subjetiva de rechazo o dificultad para establecer vínculos sostenidos con sus pares. Esta experiencia puede afectar su autoestima y limitar su participación social espontánea.
Historia socio-afectiva La paciente presenta una vinculación afectiva adecuada con figuras significativas y expresa conductas prosociales como preocupación por el bienestar de los otros. Se observa una disposición afectiva positiva, caracterizada por actitudes amorosas y colaborativas. Sin embargo, frente a estímulos emocionales o preguntas que generan excitación, se evidencia una respuesta de risa desproporcionada, acompañada de desviación de la mirada y apertura bucal, lo cual podría estar asociado a una desregulación emocional leve o a un patrón atípico de respuesta afectiva. Aunque manifiesta una comprensión adecuada de instrucciones verbales y situaciones concretas, presenta limitaciones en el procesamiento y comprensión lectora de textos extensos, lo que sugiere posibles dificultades en los procesos cognitivo-lingüísticos relacionados con la decodificación y el análisis semántico.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se aplicó entrevista semiestructurada a la madre con el fin de indagar antecedentes médicos, desarrollo psicomotor, dinámicas familiares, redes de apoyo, funcionamiento en contextos cotidianos y aspectos socioafectivos relevantes. Asimismo, se empleó la técnica de observación directa y juego dirigido para favorecer la interacción con la paciente, permitiendo identificar elementos relacionados con su comunicación verbal y no verbal, regulación emocional, capacidad atencional, contacto ocular, organización del pensamiento y formas de vinculación. Durante la evaluación, se evidenciaron dificultades en la articulación de algunos fonemas, principalmente el fonema /r/, comprensión parcial de instrucciones complejas, la paciente se mostró colaboradora, sin oposición al vínculo terapéutico, aunque con tiempos fluctuantes de atención conjunta y respuestas emocionales intensas frente a estímulos que le generan interés o sorpresa. Dada la sintomatología observada e información referida por la madre se sugiere la realización de una evaluación neuropsicológica para caracterizar el perfil cognitivo general de la paciente, así como la aplicación del protocolo ADOS-2 (Schedule for Autism Diagnostic Observation) con el fin de confirmar o descartar la presencia de trastorno del espectro autista en la niñez. Esta valoración permitirá precisar el diagnóstico clínico y orientar una intervención ajustada a sus necesidades individuales y al contexto familiar.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

Consulta primera vez por Neurólogo Infantil el 3 mayo 2021 con impresión dx Deficit de atención y del desarrollo del leguaje. Dr. Jesualdo Morelli.

Intervención neuropsicológica

No refiere

Otras intervenciones

Atención por Terapia ocupacional 21 feb 2024, con Dx F819 Trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, no especificado. Dra. Elibeth Valencia Meza.
Atención por Fonoaudiología 21 feb 2024, con Dx F819 Trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, no especificado. Dra. helen Gonzalez Suarez.
Atención por Psicología 21 feb 2024, con Dx F819 Trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, no especificado. Dra. Diana Rangel Clavijo

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

La paciente ingresa a consulta en compañía de la madre. Presenta un saludo adecuado, con expresión facial sonriente, escasa comunicación verbal espontánea y postura sedente estable durante toda la sesión, sin desplazamientos innecesarios. Responde a las preguntas formuladas de manera tímida pero colaboradora. Se evidencia atención sostenida durante los momentos de interacción, con lenguaje verbal limitado por dificultades en la articulación de ciertos fonemas y sílabas, particularmente con el fonema /r/. Comprende instrucciones básicas de forma adecuada. Se encuentra orientada autopsíquicamente, con contacto ocular intermitente, pensamiento concreto, sin alteraciones sensorperceptivas evidentes ni ideación delirante. Afecto congruente con la situación y juicio acorde a su edad cronológica. No se reportan ideas de daño, autolesión ni alteraciones de la conciencia durante la sesión.

Ciclos del Sueño

Normales

Apetito

Normal (con preferencia frente alguno alimentos en específicos)

Actividades de Autocuidado

Independiente con supervisión

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Establecido por primera vez

Si

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Promover el desarrollo integral de la paciente mediante la estimulación de sus habilidades cognitivas, comunicativas, emocionales y sociales, favoreciendo su adaptación funcional en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.

Objetivos Específicos

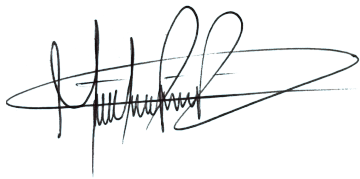
- **Fortalecer las habilidades de comunicación verbal y comprensión del lenguaje**, mediante estrategias lúdicas, visuales y estructuradas que permitan mejorar la articulación y la expresión oral.
- **Establecer rutinas terapéuticas para el fortalecimiento de funciones cognitivas básicas**, como la atención, la memoria de trabajo y el seguimiento de instrucciones.
- **Favorecer el reconocimiento, expresión y regulación emocional**, a través de actividades que permitan identificar sus emociones y las de los demás, promoviendo la empatía y el autocontrol.
- **Estimular las habilidades sociales y la interacción grupal positiva**, con el fin de mejorar la integración con sus pares y reducir la percepción de rechazo, fortaleciendo su autoestima y sentido de pertenencia.

Sugerencias e Interconsultas

- Interconsulta con Neuropsicología Clínica (Aplicación de prueba Neuropsicológica completa y protocolo ADOS-2).
- Interconsulta con Psiquiatría Infantil.

Observaciones y Recomendaciones

- Aplicar batería de evaluación neuropsicológica para identificar su perfil cognitivo y detectar posibles dificultades en funciones ejecutivas, atención y comprensión.
- Aplicación del instrumento **ADOS-2** para confirmar o descartar diagnóstico dentro del espectro autista.
- Acompañamiento familiar para fortalecer los factores protectores.
- Coordinar con el colegio un plan de seguimiento y aplicación de PIAR específicamente en las asignaturas que requieran comprensión e interpretación.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica

Tarjeta Profesional: 259542

Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER